

TD Traumatologie — QCD/QCM (L2)

TRAVAUX DIRIGÉS — ÉVALUATION OBJECTIVE

TRAUMATOLOGIE — Prise en charge infirmière des Pathologies Chirurgicales

INFAS — Licence 2 Infirmier(e) Diplômé(e) d'État (L2 IDE)

Nom & Prénoms : Date :

.....

Consigne : Questions 1-35 : indiquer Vrai (V) ou Faux (F). Questions 1-25 : cocher la seule réponse exacte (A, B, C ou D). Barème : 1 point/question — Total : 60 points.

Chapitres couverts : Thorax | Clavicule | Épaule | Humérus | Avant-bras | Fémur | Jambe | Ménisques | Rotule | Bassin | Choc traumatique | Voie publique | Polytraumatisé

I. QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD) — VRAI OU FAUX (35 questions)

1. Le traumatisme thoracique par mécanisme direct entraîne surtout une lésion viscérale. V[] F[]
19. Les fractures des deux os de la jambe sont des fractures extra-articulaires. V[] F[]
2. L'hémothorax donne une matité à la percussion, le pneumothorax une hypersonorité. V[] F[]
20. Un choc direct par écrasement provoque le plus souvent une fracture spiroïde de la jambe. V[] F[]
3. Une simple contusion thoracique ne nécessite aucune surveillance particulière. V[] F[]
21. Le ménisque interne a une forme en C, le ménisque externe une forme presque en O. V[] F[]
4. La fracture du tiers moyen représente environ 75 % des fractures de la clavicule. V[] F[]
22. Le signe d'Oudard (« cri méniscal ») correspond à une douleur à la palpation de l'interligne articulaire. V[] F[]
5. Chez l'enfant, la fracture de la clavicule consolide en trois semaines (bois vert). V[] F[]
23. La rotule est reliée au fémur par le ligament rotulien et à la jambe par le tendon quadricipital. V[] F[]
6. Devant une fracture de la clavicule, il est indispensable de rechercher une mobilité anormale. V[] F[]
24. La majorité des fractures de la rotule nécessitent un traitement chirurgical. V[] F[]
7. La luxation antéro-interne est la variété la plus fréquente des luxations de l'épaule. V[] F[]
25. Les traumatismes du bassin exposent à des complications vasculo-nerveuses et urinaires graves. V[] F[]
8. Le signe de Berger correspond à l'impossibilité de réaliser l'adduction du bras. V[] F[]
26. Le traitement orthopédique du bassin peut comporter un repos au lit sur plan dur pendant 45 jours. V[] F[]
9. La luxation de l'épaule n'est jamais considérée comme une urgence orthopédique. V[] F[]
27. Une fracture du bassin ne peut jamais s'accompagner d'un état de choc hémodynamique. V[] F[]
10. La contracture de Volkmann est la complication la plus grave des fractures supracondyliennes de l'humérus. V[] F[]
28. En phase primaire (pré-choc), on observe une hémococoncentration avec élévation de l'hématocrite. V[] F[]
11. Le nerf radial peut être lésé dans les fractures du corps (diaphyse) de l'humérus. V[] F[]
29. En phase de choc compensé, la diurèse est habituellement supérieure à 100 ml/heure. V[] F[]
12. Les fractures de l'humérus se traitent uniquement par méthode orthopédique, jamais par chirurgie. V[] F[]

30. La pression veineuse centrale normale se situe entre 3 et 8 cm H₂O. V[] F[]
13. La fracture de Pouteau-Colles touche l'extrémité inférieure du radius, surtout chez le sujet ostéoporotique. V[] F[]
31. Un pouls accéléré, petit et filant malgré le traitement est un signe de bon pronostic. V[] F[]
14. Le syndrome de Volkmann débutant impose de renforcer le plâtre pour calmer la douleur. V[] F[]
32. Empoigner un blessé sous les aisselles peut provoquer la chute de la langue en arrière. V[] F[]
15. Les fractures de l'avant-bras chez l'enfant sont souvent incomplètes, dites en bois vert. V[] F[]
33. Il faut donner à boire au blessé de la route pour éviter la déshydratation pendant le transport. V[] F[]
16. Chez l'enfant de moins de 5 ans, la fracture du fémur peut être traitée par traction au zénith. V[] F[]
34. « Polytraumatisé » et « poly-fracturé » sont des termes strictement synonymes. V[] F[]
17. Les méthodes orthopédiques sont le traitement de première intention des fractures du fémur de l'adulte. V[] F[]
35. Chez le polytraumatisé, la ponction-lavage ou l'échographie abdominale doit être un geste systématique. V[] F[]
18. La surveillance des redons doit vérifier l'absence de bulles d'air, gage d'étanchéité. V[] F[]

II. QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM) (25 questions)

1. Parmi ces examens, lequel n'appartient PAS au bilan initial d'un traumatisme thoracique ?
- A. Radiographie thoracique de face
 - B. Scanner thoracique
 - C. Numération formule sanguine (NFS)
 - D. Coloscopie
2. Quel signe clinique évoque un hémopéricarde avec tamponnade cardiaque ?
- A. Hypersonorité à la percussion
 - B. Bruits du cœur assourdis et pouls petit et filant
 - C. Murmure vésiculaire augmenté
 - D. Voix cassée isolée
3. Quelle est la fréquence des fractures du tiers externe de la clavicule ?
- A. 1 à 3 %
 - B. 20 %
 - C. 75 %
 - D. 50 %
4. Quel moyen de contention orthopédique est cité pour une fracture simple de la clavicule ?
- A. Traction au zénith
 - B. Bandage en huit de chiffre
 - C. Plâtre pelvi-pédieux
 - D. Attelle de Böhler
5. Quel signe correspond à l'aplatissement du moignon de l'épaule avec coup de hache externe ?
- A. Signe de Berger
 - B. Signe de l'épaulette
 - C. Signe d'Oudard
 - D. Attitude de Dessault

6. Après réduction d'une luxation antéro-interne de l'épaule, l'immobilisation dure habituellement :

- A. 24 à 48 heures
- B. 1 à 2 semaines
- C. 3 à 6 semaines
- D. 6 mois

7. Dans quelle fracture de l'humérus le nerf médian et l'artère brachiale sont-ils particulièrement menacés ?

- A. Fracture du corps (diaphyse)
- B. Fracture supracondylienne
- C. Fracture de l'olécrâne
- D. Fracture de la tête humérale

8. La cause la plus fréquente de la contracture de Volkmann est :

- A. Une infection osseuse
- B. Une compression et lésion de l'artère brachiale
- C. Une atteinte du nerf phrénique
- D. Une lésion du nerf récurrent

9. La fracture de Pouteau-Colles touche :

- A. La tête radiale
- B. L'extrémité distale (inférieure) du radius
- C. L'olécrâne
- D. La diaphyse du cubitus

10. Devant un syndrome de Volkmann débutant, le geste qui s'impose en urgence est de :

- A. Renforcer le bandage
- B. Surélever fortement le membre
- C. Retirer immédiatement tout appareillage compressif
- D. Attendre 24 heures avant d'agir

11. Pour une fracture du fémur à composante transversale du tiers moyen, l'ostéosynthèse utilisée est :

- A. Une plaque vissée
- B. Un fixateur externe
- C. Un clou centromédullaire
- D. Une broche de Kirschner

12. L'ablation d'une prothèse métallique du fémur est généralement envisagée après :

- A. 15 jours
- B. 1 mois
- C. 6 mois à 1 an
- D. 5 ans

13. La fracture spiroïde de la jambe résulte le plus souvent :

- A. D'un écrasement direct
- B. D'une flexion-torsion (ex : ski)
- C. D'une chute sur la main
- D. D'une compression du bassin

14. Le grand plâtre du traitement orthopédique d'une fracture de la jambe s'étend :

- A. Du genou à la cheville
- B. Du tiers moyen de la cuisse aux orteils
- C. De la hanche au genou
- D. De la cheville aux orteils seulement

15. Quelle manœuvre recherche une lésion de la partie postérieure du ménisque interne par un déclic ?

- A. Manœuvre de Mac Murray
- B. Signe de Berger
- C. Grinding test d'Appley
- D. Signe de l'épaulette

16. Le grinding test d'Appley se pratique chez un patient :

- A. Debout, en appui monopodal
- B. Assis, jambe pendante
- C. En décubitus ventral, genou fléchi
- D. En décubitus dorsal, jambe tendue

17. La patella (rotule) est décrite comme :

- A. Le plus petit os sésamoïde du corps humain
- B. Le plus gros os sésamoïde du corps humain
- C. Un os long du membre inférieur
- D. Un os plat du bassin

18. Un mécanisme de compression latérale sur le bassin entraîne le plus souvent :

- A. Une rotation externe des hémibassins
- B. Une rotation interne d'un ou des deux hémibassins
- C. Une fracture isolée du coccyx
- D. Une luxation de la hanche

19. Dans le traitement orthopédique du bassin, la suspension en hamac dure :

- A. 7 jours
- B. 21 jours
- C. 45 jours
- D. 60 jours

20. La phase de choc compensé se caractérise notamment par une pression artérielle inférieure à :

- A. 100 mmHg
- B. 70 mmHg
- C. 50 mmHg
- D. 40 mmHg

21. Une septicémie à germe Gram négatif (ex : salmonella) provoque un choc de type :

- A. Cardiogénique
- B. Hypovolémique
- C. Septique (bactérien)
- D. Anaphylactique

22. Le débit urinaire minimal recherché chez un patient en état de choc est de :

- A. 10 ml/h
- B. 50 ml/h
- C. 100 ml/h
- D. 200 ml/h

23. Lors du ramassage d'un traumatisé de la route, le rachis cervical doit être maintenu :

- A. En flexion forcée
- B. En rectitude, par traction axiale
- C. En rotation latérale rapide
- D. En extension forcée puis rotation

24. Le polytraumatisé se définit exactement comme un blessé :

- A. Présentant une seule fracture grave
- B. Présentant plusieurs fractures sans risque vital
- C. Présentant plusieurs traumatismes dont un au moins engage le pronostic vital
- D. Présentant uniquement des plaies cutanées multiples

25. Chez le polytraumatisé en détresse circulatoire, le cathéter du système cave supérieur permet surtout de :

- A. Réaliser uniquement des injections intramusculaires
- B. Surveiller la PVC et assurer perfusions/transfusions
- C. Remplacer la sonde vésicale
- D. Éviter la radiographie pulmonaire

CORRIGÉ

QCD (1 à 35)

- 1 – F
- 2 – V
- 3 – F
- 4 – V
- 5 – V
- 6 – F
- 7 – V
- 8 – V
- 9 – F
- 10 – V
- 11 – V
- 12 – F
- 13 – V
- 14 – F
- 15 – V
- 16 – V
- 17 – F
- 18 – V
- 19 – V
- 20 – F

21 – V

22 – V

23 – F

24 – V

25 – V

26 – V

27 – F

28 – V

29 – F

30 – V

31 – F

32 – V

33 – F

34 – F

35 – V

QCM (1 à 25)

1 – D

2 – B

3 – B

4 – B

5 – B

6 – C

7 – B

8 – B

9 – B

10 – C

11 – C

12 – C

13 – B

14 – B

15 – A

16 – C

17 – B

18 – B

19 – B

20 – B

21 – C

22 – B

23 – B

24 – C

25 – B